

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Peter Wagner geb.: 21.03.1951 ID: STT-OES-0426-001 Fall-ID: FALL-OES-01

Datum der Untersuchung:

10.04.2026

Tumornachsorgekalender-Nr:**ausgestellt am:**

10.04.2026

Überweiser:

St. Josef Musterklinik

Primärdiagnose:

03/2026

Primärtumor:

C15.5 - Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel, diagnostiziert 10.04.2026 (Aktiv)

Histologie des Primärtumors:

AEG, G3, Claudin 18.2 / Her2+

TNM bei Erstdiagnose:

cM0

**aktuelle Lokalisation:
(z.B. Metastase/Rezidiv)**

40-43 cm a.o.

TNM-Stadium:**THERAPIEVERLAUF:** (Zeitraum, Schema + Zyklen bzw. Dosis bei Radiatio)

Stationär bei Kolon-Ca.

23.02.2026: Gastroskopie: 43-40 cm a.o., tumorös veränderte Schleimhaut.

23.02.2026: CT-Thorax/Abdomen: kein sicherer Hinweis auf Filialisierung, suspekte LK im Bereich des thorakalen Ösophagus.

24.02.2026: Abdomen-Sono: V. a. hepatische Filialisierung.

25.02.2026: PEG-Anlage.

27.03.2026: Kein Nachweis hepatischer Metastasierung.

30.03.2026: CEA 2,85 ng/ml // CA 19-9 71,2 U/ml.

ALLGEMEINANAMNESE: (Familienanamnese, Risikofaktoren, Vorerkrankungen, Operationen, usw.)

VE: Kolon-Ca, Acoxia-Allergie, DM II, VHF mit Apixaban, Hyperthyreose, OSAS mit CPAP. SA: verheiratet, 2 gesunde Söhne, Beruf Fernmeldeamt, kein GdB/PS I. NA: 1-3 Bier pro Tag, wohl kein Nikotin.

Allergien:**Allergien:**☒ ja☐ nein**Schrittmacher:**☐ ja☒ nein**Port/PEG:**☒ ja, PEG☐ nein**Betreuung:**☐ ja☒ nein**TUMORANAMNESE/aktuelle Beschwerden:**

Aktuell lediglich weiche Kost / flüssige Nahrung möglich, hierunter Gewichtsverlust um 6 kg innerhalb von 6 Wochen.

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Peter Wagner geb.: 21.03.1951 ID: STT-OES-0426-001 Fall-ID: FALL-OES-01

STT-Verordnung vom: 10.04.2026 Patient/in: Peter Wagner ID: STT-OES-0426-001

AKTUELLER STATUS:**Karnofsky-Index:**

70% - Arbeitsunfähig, jedoch selbstständig im Alltag. (Karnofsky)

Größe:

176 cm

Gewicht:

92 kg

Zuhause vollständiger Selbstversorger, keine sensomotorischen Defizite.

BESTRAHLUNGSVERORDNUNG:

Begründung der Strahlentherapie - Indikation:

☒ kurativ☐ palliativ☐ gutartig

Zielvolumen und Dosierung:

Alleinige kleinvolumige RT des AEG-Tumors mit 2 - 2,5 Gy bis 50-60,0 Gy in Abhängigkeit der Toleranz.

Simultane Systemtherapie:

X nein ; ja,

Vorbestrahlung
(wann/Lokalisation/Dosis):

X nein ; ja,

☒ Kontakt SozDienst besprochen/Infoblatt ausgehändigt**ausgebender Arzt:**

Dr. Sarah Klein

auswärtige Bildgebung:☐ eingelesen:**Bestrahlungsgerät:**☐ L1☐ L2☒ L3☐ AL/Intrabeam**Termine:**

Planungs-CT / Maske / Markierung:

15.04.2026 11:00 Uhr

Ersteinstellung:

23.04.2026 11:00 Uhr

Labor vor Chemo:

Tagesklinik:

Station:

Sonstiges:

Datum: 10.04.2026 11:10:05**erstellender Arzt:**

Dr. Tobias Braun

Datum: 10.04.2026 12:49:08**F-/O-Arzt:**

Dr. Sarah Klein



Musterklinik und Poliklinik für Strahlentherapie

CT-Anforderung

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Peter Wagner geb.: 21.03.1951 ID: STT-OES-0426-001 Fall-ID: FALL-OES-01

CT-Anordnung vom:

10.04.2026

Anordnender Arzt:

Dr. Tobias Braun

DIAGNOSE:

Primär C15.5 - Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel, diagnostiziert 10.04.2026 (Aktiv)

Behandlungsindikation:

Oesophagus Ca distal

LAGERUNGS- UND SCANVORGABE: REGION:

☐ Schädel ☐ Hals ☐ Thorax ☒ Abdomen ☐ Becken ☐ 4D-Atemstudie ☐ DIBH

☐ Spezielle Anforderung Region:

☐ bei Erreichen einer GHD von

Gy

☐ am:

☐ Extremitäten:

☐ Ganzkörper-CT:

☐ bitte Arzt hinzurufen

(Soll ein Flap aufgelegt werden, z. B. Basaliom Kopfregion, muss der Flap durch den Ambulanzzarzt VOR dem Planungs-CT aufgelegt werden. Bei Basaliom Nasen-/Ohrregion bitte statt Flap Planungs-CT mit Moulage.)

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: Wingstep	☐ Knee step
☐ Maske	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung
☐ Wing step	☐ Anusmarkierung
☒ Knierolle	☐ Drahtmarkierung
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen	☐ Bellyboard

Datum: 10.04.2026 10:44:58

erstellender Arzt:

Dr. Tobias Braun

Datum: 10.04.2026 12:49:50

F-/O-Arzt:

Dr. Sarah Klein

Die Planungs-CT ist Bestandteil der Bestrahlungsplanung und der dazugehörigen Patientenaufklärung.

Fiktive Patientendaten - ausschließlich für Ausbildung/Simulation Patient/in: Peter Wagner geb.: 21.03.1951 ID: STT-OES-0426-001 Fall-ID: FALL-OES-01

Datum der Untersuchung: 15.04.2026

Gewicht Patient:

92 kg

Ganzkörper-CT:

☐ Patientendurchmesser < 30 cm

☐ Patientendurchmesser > 30 cm (Probeliegen bei Erstgespräch)

Referenzpunkt:

Tischhöhe:

13 cm

Lagerung:

☐ Bauchlage	☐ Belly step
☒ Rückenlage	☐ Pro step
☒ Arme: Wingstep	☐ Knee step
☐ Maske	☐ Schultermarker
☐ Nackenschale	☐ Blasenfüllung
☐ Wing step / Ring	☐ Anusmarkierung
☒ Knierolle	☐ Drahtmarkierung
☐ Bluebag	☐ Vaginaltampon
☐ Flap/Moulage	☐ Kopfschale
☐ Zahnschienen	☐ blaue Matte
☐ Bauchpresse	☐ 4D-Atemstudie
☐ schiefe Ebene	☐ Bellyboard
☐ DIBH	
☐ Name Atemkurve	

Thorakoabdomineller Scanbereich bei distalem Ösophagus-/AEG-Tumor. PEG beachten. Patient in Rückenlage, Arme im Wingstep.

Nach Durchführung der CT verpflichtende Kontrolle (DA)

kontrolliert:

1. Wirbelsäule optisch und im Scout gerade gelagert?
Keine metallischen Lagerungshilfen im Bild?



2. Ref-Markierung (Bleikugeln) im CT-Schnitt auf einer Schicht?



3. Blasen-/Rektumfüllung kontrolliert?



4. KM-Reste Darm/Blase -> Arzt dazu



5. Ganzer Patientenumfang wird rekonstruiert?



6. Bei Kontroll-CT: Was wurde mit Bleikugeln markiert?



Datum: 15.04.2026 11:22:00

MTRA: Marlon Fuchs

Datum: 15.04.2026 11:47:00

F-/O-Arzt: Dr. Laura Mertens